La goutte

Le cours reconstruit à partir des QCM : ce qui est demandé, les pièges, et seulement l'essentiel du cours.

Comment lire ce cours

TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; ×N = nombre de fois où il apparaît dans la banque et le recueil corrigé (doublons entre sessions inclus, ordre de grandeur). Priorité : ★★★ ≥ 10 questions, ★★ 5 à 9, ★ moins de 5.

✔ = proposition juste · ✘ = proposition fausse (les pièges). Les encadrés rouges signalent les contradictions entre le cours, la banque et le corrigé.

À propos du contenu

- Le cours (44 diapositives, plusieurs sont des schémas) suit le plan : définition, épidémiologie, physiopathologie, diagnostic positif, étiologique et différentiel, traitement (crise puis traitement hypo-uricémiant), suivi.
- La banque contient environ **70 QCM** dans le chapitre « Rhumatismes métaboliques (goutte) » (beaucoup de doublons d'une session à l'autre) et une dizaine d'autres dans d'autres chapitres. Le corrigé en détaille 12 (sessions 2017 à 2026).
- Quelques points testés ne sont pas dans votre cours (chondrocalcinose, hyperuricémie asymptomatique, détails des uricosuriques) : je les ai ajoutés à partir des QCM, signalés « hors cours ».

Les 10 points à connaître avant tout

1. Goutte = **rhumatisme microcristallin** par dépôts d'**urate monosodique**, conséquence d'une **hyperuricémie chronique** (> 360 µmol/l = 60 mg/l). Hyperuricémie = cause nécessaire mais **non suffisante**.
2. **Prédominance masculine** (40–50 ans) ; la femme après la ménopause. Jamais « plus fréquente chez la femme ».
3. Crise typique : **monoarthrite aiguë du membre inférieur**, surtout **1re MTP (gros orteil)**, début **brutal**, souvent **nocturne**, inflammation et douleur intenses, maximum en < 24 h. Mais pas « toujours » le gros orteil.
4. Pendant la crise, l'**uricémie peut être normale** : la refaire 14 à 20 jours après. Radiographies **normales** au début.
5. Liquide synoviral **inflammatoire (> 2000/mm³), stérile**, avec **cristaux d'urate** fins, allongés, pointus, **fortement biréfringents** : c'est l'**examen de référence**.
6. **Tophus** et arthropathie = goutte **chronique** (≈ 10 ans), jamais la goutte aiguë. Atteinte rénale : lithiase urique **radiotransparente**, néphropathie goutteuse.
7. Crise : **colchicine** le plus tôt possible (≤ 12 h) ± AINS ± corticoïdes. **Jamais allopurinol** ni febuxostat dans la crise. Premier signe de toxicité de la colchicine : **diarrhée**.
8. Traitement de fond = **hypo-uricémiant (THU) à vie** : allopurinol (inhibe la xanthine oxydase) ou febuxostat ; uricosuriques en 2e ligne. Démarrage **sous couverture de colchicine**, pas le 1er jour de la crise.
9. **Hygiène de vie à vie** : perte de poids, arrêt de l'alcool et des sodas sucrés, peu de viande, abats, poissons gras. Le régime est **hypocalorique, pauvre en purines** (jamais « hypercalorique, hyperpurinique »).
10. **Diagnostic différentiel** d'une crise : d'abord l'**arthrite septique** ; puis chondrocalcinose (cristaux de pyrophosphate de calcium) et rhumatismes inflammatoires.

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréquence	Priorité
Traitement de la crise et colchicine (indications, rôle, effets)	≈ 20	★★★
Traitement de fond : THU, objectif, couverture par colchicine, régime	≈ 18	★★★
Tophus, lithiase, radiographie : goutte aiguë vs chronique	≈ 16	★★★
Crise aiguë typique : siège, début, terrain, uricémie normale	≈ 14	★★★
Facteurs favorisants (alcool, thiazidiques, IRC, purines)	≈ 6	★★

Thème	Fréquence	Priorité
Physiopathologie : acide urique, hyperproduction/excrétion, allopurinol	≈ 6	★★
Liquide synovial et diagnostic de certitude	≈ 6	★★
Chondrocalcinose (diagnostic différentiel)	≈ 8	★★
Cas cliniques d'hyperuricémie asymptomatique et diététique	≈ 5	★

1 · Définition et épidémiologie TOMBE EN QCM ×4 ★

	À retenir (cours)
Définition	Rhumatisme **microcristallin** : dépôts articulaires, péri-articulaires, osseux ou cutanés de microcristaux d'**urate de sodium**
Cause	**Hyperuricémie chronique > 360 µmol/l (60 mg/l)**
Terrain	Prévalence et incidence **en augmentation** ; **prédominance masculine** ; homme de 40 à 50 ans, femme **après la ménopause**
Goutte primitive	Associée au surpoids et au **syndrome métabolique** ; antécédents familiaux dans **30–40 %** ; évolution non obligatoirement bénigne (hors cours, corrigé 2024)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Terrain et définition**

- ✔ Goutte = maladie à **cristaux d'urate** ; prédominance **masculine**
- ✔ Goutte primitive : association fréquente aux éléments du **syndrome métabolique** ; **antécédents familiaux 30–40 %**
- ✔ L'**hyperuricémie est la cause nécessaire mais non suffisante** (conclusion du cours)
- ✘ Plus fréquente chez la **femme** que chez l'homme
- ✘ Goutte = rhumatisme **dégénératif** chronique
- ✘ Goutte = dépôts de cristaux de **pyrophosphate de calcium** (c'est la chondrocalcinose)
- ✘ Évolution « obligatoirement bénigne » ; prédominance féminine ; « fréquents déficits enzymatiques »

2 · Physiopathologie TOMBE EN QCM ×14 ★★

Facteurs de risque (cours) : hyperuricémie chronique, facteurs génétiques, âge, alimentation, alcool, médicaments, comorbidités.

Catégorie	Exemples
Alimentation	Régime riche en **purines** : viandes, abats, fruits de mer, **bière**, **alcools forts**, **sodas sucrés**
Médicaments	**Diurétiques** (thiazidiques surtout), **aspirine à faible dose**, chimiothérapie, **pyrazinamide**, **éthambutol**, IEC, bêtabloquants, ciclosporine, antirétroviraux
Comorbidités	**Syndrome métabolique**, obésité, maladies cardiovasculaires, **insuffisance rénale chronique**

Métabolisme de l'acide urique

- L'acide urique est le **produit final du catabolisme des bases puriques** (pas des protéines, ni des bases pyrimidiques). L'homme n'a pas d'uricase : l'urate n'est pas dégradé.
- **Apports :** synthèse endogène de novo (foie ++, enzymes HGPRT et PRPP synthétase) + purines alimentaires. **Élimination :** rénale (≈ 70 %, transporteurs URAT1, GLUT9, ABCG2, NPT1/4) et digestive (uricolyse bactérienne).
- **Xanthine oxydase :** transforme hypoxanthine → xanthine → acide urique ; c'est la cible de l'**allopurinol** et du **febuxostat**.
- Hyperuricémie par **hyperproduction** (synthèse excessive, catabolisme excessif des acides nucléiques) ou par **défaut d'élimination rénale** (le plus fréquent).

Pathogénie de la crise

- Seuil de cristallisation de l'urate monosodique : **360 µmol/l (60 mg/l) à 35 °C** ; la cristallisation commence progressivement au-dessus de ce seuil.

- Les microcristaux libérés dans l'articulation activent l'**inflammasome NLRP3** : production de cytokines pro-inflammatoires, **IL-1 +++**. D'où l'intérêt des inhibiteurs de l'IL-1 dans les formes réfractaires.
- Goutte chronique : inflammation chronique entretenue par les **tophus au contact de l'os**.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×7 **Physiopathologie**

- ✔ Facteurs favorisants : **alcool**, **insuffisance rénale chronique**, **régime riche en purines**, **diurétiques thiazidiques**
- ✔ La goutte résulte d'une **synthèse excessive** d'acide urique, d'un **catabolisme excessif des acides nucléiques** ou d'un **défaut d'élimination rénale**
- ✔ L'hyperuricémie peut survenir sous **diurétiques**
- ✔ L'**allopurinol** agit par inhibition de la **xanthine oxydase** (et baisse la purinosynthèse de novo)
- ✔ Les microcristaux se forment à partir de **70 mg/l** (version de la banque)
- ✘ **Sexe féminin avant la ménopause** comme facteur favorisant
- ✘ Acide urique = terme ultime du catabolisme des **protéines** ; produit final des bases **pyrimidiques**
- ✘ Déficit en **urate-oxydase** ou en **xanthine-oxydase** comme cause de goutte
- ✘ Allopurinol qui « inhibe la réabsorption tubulaire » ou « stimule l'uricase »

PIÈGES

Seuil de cristallisation. Le cours dit 360 µmol/l (60 mg/l). Une question de la banque (sessions diverses) donne « **70 mg/l** » comme juste. Si l'option contient un des deux chiffres sans autre piège, elle est à cocher.

Cardiopathie ischémique. Le cours range « maladies cardiovasculaires » parmi les comorbidités ; le corrigé (2022) donne pourtant **cardiopathies ischémiques** comme l'exception dans « facteurs de risque sauf ». Dans une liste avec hyperuricémie, déficit enzymatique, alcool, surpoids : c'est elle la réponse.

3 · Clinique : la crise de goutte TOMBE EN QCM ×16 ★★★

Caractère	À retenir
Siège	**Membre inférieur** dans 90 % des cas au début ; **monoarthrite aiguë** (90 %). **MTP de l'hallux ++++**, tarse, cheville, puis genou. Peut inclure bourses séreuses et tendons
Début	**Brutal**, souvent **nocturne** ; **impotence fonctionnelle** ; prodromes possibles (malaise, irritabilité, picotements)
Intensité	Inflammation locale forte (**rougeur**), douleur ≥ 7/10, hypersensibilité à la palpation ; maximum en **moins de 24 h**
Général	Fièvre possible jusqu'à 39 °C
Évolution	**Résolution spontanée** en quelques jours à quelques semaines (corrigé : 7 à 10 jours), restauration **ad integrum** au début. **Récidive** sans THU
Au fil du temps	Récidives oligo- voire polyarticulaires (mains, poignets), moins franches mais plus prolongées, intervalles libres plus courts. Hanches, épaules, rachis : **exceptionnels**
Facteurs déclenchants	Alcool, repas riche, diurétiques thiazidiques, traumatisme, et **début ou modification d'un THU**

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×16 **Crise aiguë typique**

- ✔ Début **brutal**, souvent **nocturne**, avec impotence fonctionnelle
- ✔ Signes inflammatoires locaux **intenses**
- ✔ **Atteinte du gros orteil** la plus fréquente ; atteinte des **membres inférieurs** la plus caractéristique
- ✔ Peut être **précédée de prodromes** ; **résolution spontanée** en quelques jours
- ✔ Peut s'accompagner d'une **uricémie normale**
- ✔ Parfois précédée d'**alcool** ; déclenchée par les **thiazidiques**
- ✔ Réponse **spectaculaire à la colchicine**
- ✔ Peut intéresser les **bourses séreuses** et les **tendons**
- ✘ **Toujours** localisée au gros orteil (voir pièges)
- ✘ Début progressif ; signes inflammatoires discrets
- ✘ **Bilatérale d'emblée**
- ✘ Crises plus fréquentes à l'**index**
- ✘ Réagit rapidement à l'**allopurinol**
- ✘ Liquide synovial **mécanique** (< 2000/mm³) : c'est l'intrus dans « tout est typique sauf »
- ✘ Hanches et épaules fréquemment touchées (goutte chronique)
- ✘ Insuffisance rénale aiguë « manifestation fréquente de la goutte aiguë »

La question « sauf une » sur la crise typique revient plusieurs fois (alcool, base du gros orteil, colchicine, uricémie normale sont toutes vraies ; le liquide mécanique est faux).

PIÈGES

« Toujours localisé au gros orteil ». Dans deux versions de la banque, la clé coche cette proposition juste et la proposition « parfois précédée de coliques néphrétiques » fausse. Le **corrigé (2017)** donne l'inverse : réponse **B, C, E** (colique néphrétique juste ; « toujours » faux). Je retiens le corrigé.

Colique néphrétique. Dans la même question, le corrigé accepte qu'une colique néphrétique d'origine urique précède les manifestations articulaires.

4 · Goutte chronique TOMBE EN QCM ×14 ★★★

Elle apparaît après une dizaine d'années d'évolution. Trois volets : arthropathies, tophus, atteinte rénale.

Volet	À retenir
Arthropathie uratique	Lésions articulaires secondaires à l'inflammation chronique ; douleurs mécaniques et/ou inflammatoires, **émaillées de crises**, impotence variable
Tophus	Nodules **indolores**, blancs ou chamois, d'abord mous puis durs. Sièges : **pavillon de l'oreille**, coudes, **tendons calcanéen et patellaire**, IPD, pulpe des doigts, autour des articulations. Peuvent s'inflammer et s'ouvrir à la peau (liquide **crayeux**)
Atteinte rénale	**Lithiase urique** : coliques néphrétiques, **radiotransparente**. **Néphropathie goutteuse** : protéinurie ± hématurie, insuffisance rénale, souvent HTA (tubulopathie interstitielle)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×12 **Goutte chronique vs aiguë**

- ✔ **Tophus** du pavillon de l'oreille = goutte **chronique**
- ✔ **Arthropathies destructrices des pieds** et **antécédent de lithiase rénale** en faveur d'une goutte chronique
- ✔ Les tophus traduisent une goutte chronique **non traitée**
- ✔ La **tubulopathie interstitielle** est une manifestation rénale de la goutte
- ✔ Le **dépôt d'urate** est la cause principale de l'arthropathie goutteuse ; les **géodes** peuvent être intra-osseuses
- ✔ Lithiase urique **radiotransparente**, invisible sur l'ASP
- ✘ **Tophus** manifestation fréquente ou « pathognomonique » de la goutte **aiguë**
- ✘ Tophus à l'examen d'une goutte aiguë
- ✘ Lithiase **radio-opaque**
- ✘ Insuffisance rénale ou lithiase comme manifestation de la goutte **aiguë**
- ✘ Atteinte fréquente des **hanches et épaules**
- ✘ La néphropathie goutteuse « n'évolue **jamais** » vers l'IRC
- ✘ Pincement articulaire **précoce**
- ✘ **Cristaux de pyrophosphate de calcium** en faveur de la goutte chronique

Piège fréquent : « Concernant la goutte aiguë, lesquelles sont inexactes (RF) ? » → tophus, insuffisance rénale, lithiase rénale (réponses à cocher). Les radiographies normales et l'uricémie non constante sont, elles, exactes.

5 · Examens complémentaires TOMBE EN QCM ×20 ★★★

Examen	Aigu	Chronique / remarque
Uricémie	Le plus souvent > 360 µmol/l (60 mg/l) mais **peut être normale** pendant la crise : **à refaire 14–20 jours** après	Hyperuricémie ne suffit pas au diagnostic
Biologie	**Syndrome inflammatoire** non spécifique (VS, CRP, GB)	Hémocultures négatives (sinon arthrite septique)
Liquide synovial (++++)	**Inflammatoire** : > 2000 éléments/mm³ (jusqu'à 100 000), PNN, **stérile**. **Cristaux d'UMS** fins, allongés, pointus, **très biréfringents** en lumière polarisée	Examen de référence : cristaux dans le liquide ou dans un tophus
Radiographie	**Normale** (+++) lors des premiers accès	**Géodes**, érosions épiphysaires, constructions osseuses, opacité des tissus mous (tophus), **pincement articulaire tardif**, atteinte **asymétrique**
Échographie (++)	Aspect en **double contour**, « **tempête de neige** »	Tophus des parties molles

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×18 **Biologie, liquide, imagerie**

- ✔ **Uricémie normale** possible lors de la crise ; hyperuricémie **non constante**
- ✔ Syndrome inflammatoire biologique
- ✔ Liquide **inflammatoire stérile** sans germe à l'examen direct ni en culture
- ✔ Cellularité **> 2000/mm³**, PNN altérés, microcristaux **biréfringents** en lumière polarisée
- ✔ **Radiographies normales** aux premiers accès ; lésions **asymétriques**, interligne conservé longtemps
- ✔ La présence de **cristaux d'urate** est indispensable au diagnostic de certitude
- ✔ Perturbation du liquide : **augmentation des protides** (exsudat)
- ✘ Uricémie **constante** ou « constamment normale » pendant la crise
- ✘ **Hémocultures positives**
- ✘ Cristaux de **pyrophosphate de calcium** « obligatoires »
- ✘ Dosage de l'acide urique dans le liquide synovial
- ✘ Diminution des leucocytes ou du complément ; augmentation du complément
- ✘ Cristaux « **courts** » ou « **sensibles à l'EDTA** »
- ✘ Diagnostic de certitude = « hyperuricémie > 360 µmol/l »
- ✘ Un simple cliché affirme une **crise de goutte** (il affirme chondrocalcinose et hydroxyapatite)

PIÈGES

Forme des cristaux. Cours : « fins, allongés, pointus ». Une question du cas clinique (orthopédiste, hallux) donne « courts, fins et pointus » comme **faux** : c'est « courts » qui est faux. Les cristaux de goutte ne sont pas sensibles à l'EDTA.

Diagnostic sans cristaux. Le cours liste les arguments quand la preuve microcristalline manque : terrain, crises antérieures, lithiase, facteurs déclenchants, tophus, syndrome inflammatoire, hyperuricémie, **sensibilité rapide à la colchicine** (débutée tôt), imagerie (échographie). Le QCM de cas clinique cite comme arguments : sensibilité à la colchicine, uricémie élevée, cristaux d'urate.

6 · Diagnostic étiologique et différentiel TOMBE EN QCM ×6 ★★

Goutte	Causes
Primitive	**Enzymopathique** : déficit en **HGPRT** (Lesch-Nyhan), hyperactivité de la **PRPP synthétase**, **glycogénose type I** (Von Gierke). **Néphropathie uratique familiale** (mutation de l'uromoduline). **Défaut d'excrétion rénale** : 90 % des gouttes primitives
Secondaire	**Hémopathies** chroniques, **insuffisance rénale chronique**, **médicaments** (diurétiques, ciclosporine, tacrolimus, aspirine faible dose, pyrazinamide, éthambutol). Rares : néphropathie **saturnine**, maladie de Gaucher, trisomie 21

Contexte	Diagnostics différentiels
Crise aiguë	**Arthrite septique** (+++++), rhumatisme à **pyrophosphate de calcium**, rhumatismes inflammatoires chroniques

Contexte	Diagnostics différentiels
Goutte chronique	Arthrose, nodules rhumatoïdes, chondromes, calcinose sous-cutanée

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Chondrocalcinose (hors cours, souvent opposée à la goutte)**

- ✔ Dépôt de **cristaux de pyrophosphate de calcium** ; donne une arthrite **aiguë**
- ✔ Terrain : **sujet âgé**, **calcifications méniscales** (aussi poignets, symphyse pubienne), **hyperparathyroïdie primitive**
- ✔ Traitement **médical**
- ✔ Une radiographie simple peut l'affirmer (comme le rhumatisme à hydroxyapatite)
- ✘ Chondrocalcinose due à des cristaux d'**acide urique**, de calcium, de phosphore ou de glucose
- ✘ Liquide synovial **mécanique** en cas de chondrocalcinose aiguë (il est souvent puriforme)
- ✘ Hémochromatose ou insuffisance rénale comme cause retenue dans le cas clinique

PIÈGES

Monoarthrite fébrile. Dans un cas clinique, la crise de goutte du genou n'est pas retenue en premier : il faut toujours penser d'abord à l'**arthrite infectieuse** (conséquences pronostiques).

7 · Traitement de la crise TOMBE EN QCM ×22 ★★★

Principe : traiter **le plus tôt possible** (« comprimé dans la poche »), éduquer le patient. Rechercher les comorbidités et les co-prescriptions avant de choisir.

Traitement	Modalités (cours)	Précautions
Repos, glaçage	Orthèse (décharge du membre), glace ; antalgiques en complément	
Colchicine (souvent 1re intention)	**Le plus tôt possible, idéalement dans les 12 premières heures**. **1 mg** dès le début, **0,5 mg 1 h après**, puis 0,5 mg × 2 ou × 3 par jour	**Diarrhée = 1er signe de toxicité** : réduire ou arrêter. À éviter si insuffisance rénale sévère (DFG < 30) ou inhibiteurs forts du CYP3A4/P-gp (macrolides…)
Corticoïdes	Voie orale dès le début : **30–35 mg/j équivalent prednisone**, **3 à 5 jours** ; ou infiltration intra-articulaire	Alternative si AINS ou colchicine impossibles
AINS	Dès le début, **3 à 5 jours maximum**	Éviter si maladie cardiovasculaire sévère ; IPP si indiqué
Inhibiteurs de l'IL-1	Réservés aux **échecs, contre-indications ou intolérances** aux AINS, corticoïdes et colchicine (2e ligne)	Dépister les infections, surveiller les PNN

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×20 **Traitement de la crise**

- ✔ **Colchicine** = traitement de référence de la crise ; ses effets : **anti-inflammatoire** ; peut être **remplacée par les AINS** ; sert de **test thérapeutique**
- ✔ Les traitements d'un accès aigu : **colchicine** et **AINS** (ibuprofène) ; corticoïdes en alternative
- ✔ La **décharge du membre** et la colchicine devant un premier épisode
- ✔ Effets secondaires de la colchicine : **diarrhée** (consulter si diarrhée inhabituelle) ; plus rarement leucopénie, rhabdomyolyse
- ✔ La **corticothérapie générale** ne doit être utilisée qu'**exceptionnellement** (version de la banque)
- ✘ **Allopurinol**, **febuxostat**, **uricase** / rasburicase pour le traitement de la crise
- ✘ Colchicine = **hypo-uricémiant**, ou colchicine qui « **inhibe la xanthine oxydase** » ou a une action « hyperuricémiante »
- ✘ Bandage compressif
- ✘ Les **AINS** comme traitement de fond de la goutte chronique
- ✘ Les **uricosuriques** indiqués en cas de lithiase rénale
- ✘ Colchicine contre l'algodystrophie (on prescrit la calcitonine)

PIÈGES

Colchicine ou AINS en première intention ? Le cours dit « colchicine souvent en première intention ». Le corrigé (2025) dit que **colchicine et AINS sont tous deux de première intention** (réponse C et E). Une question de la banque (« les AINS représentent le traitement de première intention ») est pourtant cochée **fausse**.

Corticoïdes. Le cours les place parmi les traitements de la crise (30–35 mg/j, 3 à 5 jours) ; la banque dit « ne doit être utilisée qu'exceptionnellement » et la coche juste. Suivre la formulation de l'énoncé.

Effets de la colchicine. Une question cote « éruption cutanée » juste ; le cours et le corrigé retiennent la **diarrhée** comme effet principal. Retenir la diarrhée.

8 · Traitement de fond : hypo-uricémiant (THU)

TOMBE EN QCM ×22

★★★

Une hyperuricémie asymptomatique ne justifie pas la mise en route d'un THU (cours). On traite la maladie goutteuse.

Élément	À retenir
Objectif	Uricémie < **300 µmol/l (50 mg/l)** chez tous les goutteux (cours) ; < **60 mg/l** dans la banque et le corrigé
Indications (corrigé 2022)	Crises **récurrentes**, **tophi**, **lithiase rénale**, **insuffisance rénale**, arthropathie chronique. Pas la stéatose hépatique
Durée	**À vie** (conclusion du cours)
Démarrage	**Pas le 1er jour de la crise** (attendre la fin de la crise) ; **couvert par la colchicine** (0,5 mg/j pendant les 6 premiers mois d'après le corrigé ; 0,3 à 1 mg/j au moins 6 mois d'après le schéma du cours) pour éviter les crises de début de traitement
Choix selon le DFG (schéma du cours)	**DFG > 60** : allopurinol 50–100 mg/j. **DFG 30–60** : allopurinol 50 mg/j ou febuxostat. **DFG < 30** : febuxostat. **Maladie cardiovasculaire sévère** : éviter le febuxostat. Augmentation progressive de la dose, uricémie contrôlée 2–4 semaines après chaque palier, jusqu'à < 300 µmol/l (allopurinol maximum 900 mg/j)
Classes	**Uricoinhibiteurs** (allopurinol, febuxostat) : inhibent la **xanthine oxydase**. **Uricosuriques** (benzbromarone) : augmentent l'excrétion rénale, **tous** exposent à un risque de lithiase urique

Mesures hygiéno-diététiques (à vie)

- Éducation du patient ; **perte de poids** si surpoids ou obésité (régime **hypocalorique** si surcharge pondérale).
- **Arrêt des boissons alcoolisées** et des **sodas sucrés** ; limiter **viande, abats, poissons gras, crustacés**.
- Dépistage et prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, du syndrome métabolique et de l'insuffisance rénale.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×24 **Traitement de fond**

- ✔ **L'initiation d'un THU doit être associée à la colchicine**
- ✔ L'objectif du THU est l'uricémie < **60 mg/l**
- ✔ Le traitement de fond repose sur : **mesures hygiéno-diététiques**, **uricoinhibiteurs**, **uricosuriques** (clé du corrigé)
- ✔ Règles hygiéno-diététiques recommandées **à vie** ; régime **hypocalorique** et pauvre en alcool
- ✔ Tous les uricosuriques induisent un risque de **lithiase urique**
- ✔ Une crise à l'instauration de l'allopurinol : liée à l'**absence de colchicine ou d'AINS** (mobilisation du pool d'acide urique) ; traitement : AINS 5 jours + allopurinol + colchicine 1 mg/j
- ✘ Allopurinol pour le traitement de l'**accès aigu** ; allopurinol « traitement de référence de la crise »
- ✘ THU instauré le **1er jour** de la crise aiguë
- ✘ Régime antigoutteux **hypercalorique, hyperpurinique**, « riche en viande », « recommandé à vie »
- ✘ Un **régime riche en purines** recommandé à vie
- ✘ Traitement de fond = AINS ou corticoïdes à faible dose
- ✘ Traiter par allopurinol ou colchicine une **hyperuricémie asymptomatique**
- ✘ Un goutteux lithiasique + hyperuricémie : première prescription = uricosurique (c'est une **diurèse abondante alcaline**)

Cas fréquents : colique néphrétique d'un goutteux avec urates → 1re prescription : diurèse abondante et alcaline. Goutteux à tophi + lithiase sous allopurinol : on ajoute la colchicine 1 mg/j pendant 1 mois (version ancienne de la banque).

PIÈGES

Objectif d'uricémie. Cours : < **300 µmol/l (50 mg/l)**. Banque et corrigé (2021) : « moins de **60 mg/l** » (= 360 µmol/l) coché juste. Dans les QCM, l'option « < 60 mg/l » est cochée juste ; si l'énoncé propose 300 µmol/l (50 mg/l), c'est la valeur du cours.

Traitement de fond : versions divergentes. Une version de la banque ne coche que « uricosuriques » (clé abîmée) ; l'autre, et le corrigé (2017), cochent **C, D, E** : mesures hygiéno-diététiques, uricoinhibiteurs, uricosuriques. Les AINS et la corticothérapie sont toujours faux.

Uricosuriques et lithiase. Une question affirme que les uricosuriques sont « indiqués en cas de lithiase » : **faux** (ils exposent à la lithiase).

Hyperuricémie asymptomatique. Un cas clinique ancien parle d'un traitement « à partir de 100 mg/l » et de régime hypocalorique, pauvre en alcool ; ni colchicine ni allopurinol. Le cours : pas de THU.

9 · Fiche flash : vrai ou faux ?

Affirmation	Réponse
La goutte est plus fréquente chez la femme.	FAUX (homme)
Elle est due à des dépôts de pyrophosphate de calcium.	FAUX (urate)
Le seuil de cristallisation de l'urate est de 60 mg/l (360 µmol/l).	VRAI
La crise touche surtout la 1re MTP, de début brutal et nocturne.	VRAI
La crise est toujours localisée au gros orteil.	FAUX
L'uricémie peut être normale pendant la crise.	VRAI
Les radiographies sont normales aux premiers accès.	VRAI
Le liquide synovial est mécanique (< 2000/mm³).	FAUX (inflammatoire)
Le liquide de la goutte est stérile.	VRAI
Les cristaux d'urate sont biréfringents en lumière polarisée.	VRAI
Le tophus est la lésion de la goutte aiguë.	FAUX (chronique)
La lithiase urique est radio-opaque.	FAUX (radiotransparente)
Les hanches et épaules sont fréquemment touchées.	FAUX (exceptionnel)
La colchicine est le traitement de référence de la crise.	VRAI
L'allopurinol traite la crise aiguë.	FAUX
Le premier signe de toxicité de la colchicine est la diarrhée.	VRAI
Le THU doit être débuté le premier jour de la crise.	FAUX
L'initiation du THU est couverte par la colchicine.	VRAI
Le régime est hypercalorique et hyperpurinique.	FAUX
Les règles hygiéno-diététiques sont recommandées à vie.	VRAI
L'allopurinol inhibe la xanthine oxydase.	VRAI
Le diagnostic différentiel principal de la crise est l'arthrite septique.	VRAI